

Valutazione questionari

Guida rapida per i colleghi – come scegliere, somministrare e calcolare i questionari clinici nella versione italiana validata

Indirizzo dell'app: <https://pollasonoio.github.io/questionari-valutazione/>

Si apre con **Google Chrome** da computer, tablet o smartphone. Non serve creare un account.

1. A cosa serve

L'app calcola i punteggi di questionari clinici (disabilità, funzione, dolore, fattori psicosociali, ritorno allo sport, qualità di vita) seguendo le istruzioni della **versione italiana validata** di ciascuno strumento, e produce un referto in PDF con grafici, spiegazione dei risultati e riferimenti bibliografici. Il paziente compila un modulo PDF (al computer, sul tablet o su carta) oppure risponde direttamente sul proprio telefono inquadrando un codice QR; il professionista carica il modulo o legge il QR con le risposte e ottiene il referto.

Privacy: i moduli caricati e i QR del paziente vengono letti ed elaborati solo nel browser del proprio computer; nessun dato viene inviato a server o salvato online. Chiudendo la pagina tutto viene cancellato. Conservi i moduli compilati e i referti secondo le regole dello studio (cartella clinica), mai nel sito dell'app.

2. Come si usa, in quattro passi

Passo 1 – Scegliere il questionario. Nella sezione «Trova il questionario» si filtra per distretto (lombare, cervicale, spalla, ginocchio, anca e inguine...) e per cosa si vuole misurare. Scegliendo un distretto compaiono prima gli strumenti specifici, poi quelli generici. Ogni scheda riporta una breve descrizione di cosa valuta il questionario, il tempo di compilazione, l'età del campione di validazione, la licenza e la fonte.

Trova il questionario

Filtri per distretto e per cosa misura; ogni scheda riporta tempo di compilazione, età del campione di validazione e licenza. Da qui si scarica il modulo vuoto, si mostra il QR per la compilazione sul telefono del paziente o si inseriscono le risposte di un modulo su carta.

Cerca per nome, distretto o cosa misura...

Distretto:

generico

lombare

cervicale

spalla

arto superiore

gomito

polso e mano

anca e inguine

ginocchio

arto inferiore

caviglia e piede

tendine d'Achille

Cosa misura:

disabilità

funzione

dolore

sintomi

psicosociale

rischio

sensibilizzazione centrale

sport

qualità di vita

☐ mostra anche gli strumenti non ancora attivi

18 strumenti

Specifici per il distretto scelto (8)

ACL-RSI

Scala ACL-RSI per la valutazione del ritorno allo sport dopo lesione del legamento crociato anteriore

Prontezza psicologica al ritorno allo sport dopo ricostruzione del crociato: emozioni, fiducia nelle proprie capacità e percezione del rischio.

ginocchio

sport

psicosociale

≈ 2 min · adulti dopo ricostruzione del LCA · libero (uso clinico)

Versione italiana: Thiebat G. et al., Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021 (Tabella 1).
doi:10.1007/s00167-021-06498-8

Scarica modulo

QR per il paziente

Inserisci risposte

IKDC

Modulo di valutazione soggettiva del ginocchio IKDC 2000

Sintomi, attività sportive e funzione del ginocchio riferiti dal paziente; usato soprattutto dopo lesioni e ricostruzione del legamento crociato.

ginocchio

sintomi

funzione

sport

≈ 10 min · adulti operati di LCA (18-42 anni nel campione) · libero (uso clinico)

Versione italiana del modulo IKDC 2000 (ESSKA/AOSSM), validata da Padua R. et al., Arthroscopy 2004;20:819-23.

Scarica modulo

QR per il paziente

Inserisci risposte

KOOS-I

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, versione italiana (KOOS-I)

Problemi del ginocchio (lesioni, artrosi) in 5 aree: sintomi, dolore, attività quotidiane, sport e attività ricreative, qualità di vita.

ginocchio

sintomi

dolore

funzione

sport

qualità di vita

≈ 10 min · ≥ 18 anni (validazione italiana) · libero (uso clinico)

Versione italiana: Monticone M. et al., Osteoarthritis Cartilage 2012;20(4):330-5 (appendice).

Scarica modulo

QR per il paziente

Inserisci risposte

Figura 1 – Catalogo filtrato per «ginocchio»: gli strumenti specifici compaiono per primi.

Guida all'app Valutazione questionari

Pagina 1

Passo 2 – Far compilare il modulo. Con «Scarica modulo» si ottiene il PDF vuoto, che il paziente può:

- compilare al computer o sul tablet (con Anteprima del Mac, Acrobat Reader o l'app File dell'iPad) e **salvare con un nome nuovo**, per esempio *KOOS-I_Cognome_data.pdf*; se Anteprima segnala che il file è protetto, scegliere «Duplica»;
- stampare e compilare a penna: in questo caso le risposte si inseriscono nell'app con «**Inserisci risposte**» (dalla scheda del catalogo o dal menu a tendina, in ordine alfabetico; circa 1 minuto);
- compilare **sul proprio telefono**: con «**QR per il paziente**» compare un codice QR (si può anche stampare) che il paziente inquadra con la fotocamera. Il paziente vede solo le domande, mai punteggi o referto. Alla fine il telefono mostra un secondo QR con le risposte: nell'app si tocca «**Leggi QR del paziente**» e lo si inquadra con la webcam del computer (Mac o Windows) o con la fotocamera del tablet o dello smartphone, tenendo il QR dentro il **riquadro verde** che compare sull'immagine. Se la fotocamera non è disponibile, si carica una foto o uno screenshot del QR. Le risposte passano da telefono a schermo, **senza internet**.

In ogni item va segnata **una sola risposta**, salvo dove il modulo chiede esplicitamente più scelte.

Passo 3 – Caricare il modulo. Si trascinano i PDF compilati nel riquadro «**Carichi i moduli compilati**» (si possono caricare più questionari dello stesso paziente insieme). Se qualcosa non va, l'app lo segnala: risposte mancanti, due caselle spuntate nello stesso item, PDF senza campi compilabili. Con «**Correggi risposte**» si sistema a mano.

1. Carichi i moduli compilati

Trascini qui i PDF compilati oppure faccia clic per sceglierli

Moduli generati per questa app, compilati al computer o sul tablet. Si possono caricare più questionari dello stesso paziente.

Oppure inserisca le risposte a mano (moduli su carta)

ACL-RSI — Scala ACL-RSI per la valutazione del ritorno allo sport dopo lesione del legamento crociato anteriore

Inserisci risposte

Oppure legga il QR del paziente

Il paziente compila sul suo telefono (pulsante "QR per il paziente" nel catalogo) e alla fine mostra un codice QR con le risposte: lo inquadri con la fotocamera di questo dispositivo. Le risposte non passano da internet.

Leggi QR del paziente

Figura 2 – Caricamento dei PDF compilati, inserimento manuale delle risposte dei moduli su carta o lettura del QR del paziente.

Passo 4 – Leggere il risultato e scaricare il referto. Per ogni questionario compaiono i punteggi con una barra grafica (posizione nel range, con il significato dei valori bassi e alti), la spiegazione «Come leggere il risultato», l'errore di misura (SEM, MDC/SDC, MIC quando disponibili) e le risposte item per item. «**Anteprima referto**» mostra il PDF; «**Scarica referto PDF**» lo salva. Il referto riporta: dati del paziente, risposte date, risultati con grafici e, in fondo alla pagina, i riferimenti bibliografici.

Scala ACL-RSI per la valutazione del ritorno allo sport dopo lesione del legamento crociato anteriore [1]

PDF: ACL-RSI_Paziente-di-prova.pdf

Paziente: Paziente di prova Compilato il: 27/09/2026

ACL-RSI, punteggio **51,7**

0 ← risposta meno favorevole risposta più favorevole → 100

Come leggere il risultato

Punteggio 51,7 su 100: più è alto, più favorevole è la risposta psicologica al ritorno allo sport (fiducia, emozioni, valutazione del rischio). Punteggio = media dei 12 item.

Validazione italiana: ICC 0,916; α di Cronbach 0,953. La versione italiana non indica un cut-off [1].

► Riferimento della letteratura, non validato in italiano

► Risposte item per item

1. Thiebat G, Cucchi D, Spreafico A, et al. Italian version of the anterior cruciate ligament-return to sport after injury scale (IT ACL-RSI): translation, cross-cultural adaptation, validation and ability to predict the return to sport at medium-term follow-up in a population of sport patients. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2021. doi:10.1007/s00167-021-06498-8
2. Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Whitehead TS, Webster KE. Psychological responses matter in returning to preinjury level of sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. *Am J Sports Med* 2013;41(7):1549-58. doi:10.1177/0363546513489284

[Correggi risposte](#) [Rimuovi](#)

3. Come leggere grafici e soglie

4. Sullo smartphone

- **iPhone (Safari):** aprire l'indirizzo dell'app, toccare **Condividi** e poi **«Aggiungi alla schermata Home»**;
- **Android (Chrome):** aprire l'indirizzo dell'app, toccare il menu (tre puntini in alto a destra) e poi **«Aggiungi a schermata Home»** (o **«Installa app»**).

5. Questionari disponibili

Questionario	Area	Cosa misura	Min.
BPFS (<i>provvisorio</i>)	lombare	funzione, disabilità	≈ 5
CPAQ	lombare	psicosociale	≈ 6
ODI-I	lombare	disabilità	≈ 5
OSPRO-YF 10	lombare	psicosociale, rischio	≈ 3
OSPRO-YF 17	lombare	psicosociale, rischio	≈ 5
OSPRO-YF 7	lombare	psicosociale, rischio	≈ 2
RMDQ-I	lombare	disabilità	≈ 5
STarT Back-IT	lombare	rischio, psicosociale	≈ 2
TSK-I	lombare	psicosociale	≈ 5
ÖMPQ-10	lombare	rischio, psicosociale	≈ 5
ÖMPQ-21	lombare	rischio, psicosociale	≈ 10
NDI-I	cervicale	disabilità	≈ 5
DASH-I	spalla	disabilità, sintomi	≈ 10
QuickDASH-I	spalla	disabilità, sintomi	≈ 3
SPADI (<i>provvisorio</i>)	spalla	dolore, disabilità	≈ 5
HAGOS-I	anca e inguine	sintomi, dolore, funzione, sport, qualità di vita	≈ 10
LEFS-I	anca e inguine	funzione	≈ 5
ACL-RSI	ginocchio	sport, psicosociale	≈ 2
IKDC	ginocchio	sintomi, funzione, sport	≈ 10
KOOS-I	ginocchio	sintomi, dolore, funzione, sport, qualità di vita	≈ 10
WOMAC	ginocchio	dolore, funzione, sintomi	≈ 10
VISA-A-I	caviglia e piede	sintomi, funzione, sport	≈ 5
CSI-I	generico	psicosociale, sensibilizzazione centrale	≈ 10
MSK-HQ (<i>provvisorio</i>)	generico	funzione, sintomi, qualità di vita	≈ 5
PCS-I	generico	psicosociale	≈ 5
PSEQ-I	generico	psicosociale	≈ 3
QUID	generico	dolore	≈ 5
SF-36	generico	qualità di vita, funzione	≈ 10

Versioni provvisorie (SPADI, MSK-HQ, BPFS): il testo proviene da moduli non verificabili sulla validazione italiana o diversi da essa; l'app lo segnala nel modulo e nel referto. **Attenzione anche a:** VISA-A italiano (10 domande, diverso dall'originale a 8), WOMAC (formato Likert; la validazione italiana ha usato la scala visiva), SF-36 (8 scale, senza indici PCS/MCS), QuickDASH (traduzione ufficiale IWH senza validazione italiana dedicata).

6. Domande frequenti

- **L'app non legge le risposte.** Usare **Chrome** (con Safari la lettura può non funzionare) e ricaricare la pagina. Verificare che il PDF sia stato **salvato** dopo la compilazione e non «stampato in PDF» (in quel caso i campi spariscono: usare «Inserisci risposte»).
- **Il QR del paziente non viene letto.** Portare al massimo la luminosità del telefono del paziente, evitare riflessi sullo schermo, tenerlo fermo a 20-40 cm dalla webcam con il QR dentro il riquadro verde e consentire l'uso della fotocamera quando il browser lo chiede. In alternativa caricare una foto o uno screenshot del QR. Se l'app segnala «versione diversa», aggiornare l'app locale (la pagina del paziente è sempre quella online).
- **Il paziente ha spuntato due risposte nello stesso item.** L'app non le considera e lo segnala: correggere con «Correggi risposte».
- **Mancano alcune risposte.** Ogni questionario segue le regole della propria validazione o degli sviluppatori: se sono troppe, il punteggio non viene calcolato e l'app spiega perché.
- **Posso usare l'app per pazienti minorenni?** Le validazioni italiane sono state condotte quasi sempre su adulti: la scheda del catalogo indica l'età del campione; interpretare con cautela.
- **Licenze.** Gli strumenti sono destinati all'uso clinico interno e non commerciale; alcune scale (es. DASH, QuickDASH, WOMAC, SF-36) hanno condizioni d'uso proprie. I moduli non vanno modificati né venduti.

Il risultato va sempre interpretato dal professionista insieme alla valutazione clinica.